

INTERVIEW PRESENTATION

대표 프로젝트 성과와 DAI 플랫폼 구축 기여 방안

AI 헬스케어 플랫폼 팀장 지원

정치성 · 2026.09.16

사용자와 현장의 문제를 제품과 운영의 개선으로 연결해 온 경험

복잡한 요구를 서비스 정책과 업무 흐름으로 구체화하고, 팀의 실행으로 연결해 왔습니다.

경험 · 도메인	사용자가 완료할 일	현장의 처리 업무	무엇을 증명하나
굿리치 보험 · 인슈어테크	보험분석을 위한 상담신청	→ 상담 활용 정보의 품질 확인	전환
THK 장기요양 · 돌봄	수급자 자격·구매 정보 조회	→ 주문·직배송의 확인과 예외 처리	운영
더베스트페이 병원 원무	예약·조회·수납	→ EMR 연동과 기관별 요구 조율	연동
코나아이 지역화폐 · 결제	지역화폐·카드 이용	→ 3개 팀 요청의 우선순위·실행 관리	조직 실행

네 곳 모두 사용자가 할 일과 현장이 처리할 일을 함께 설계했습니다. **그것이 하나의 역량입니다.**

보험분석 상담신청 페이지 전환율 20% 개선

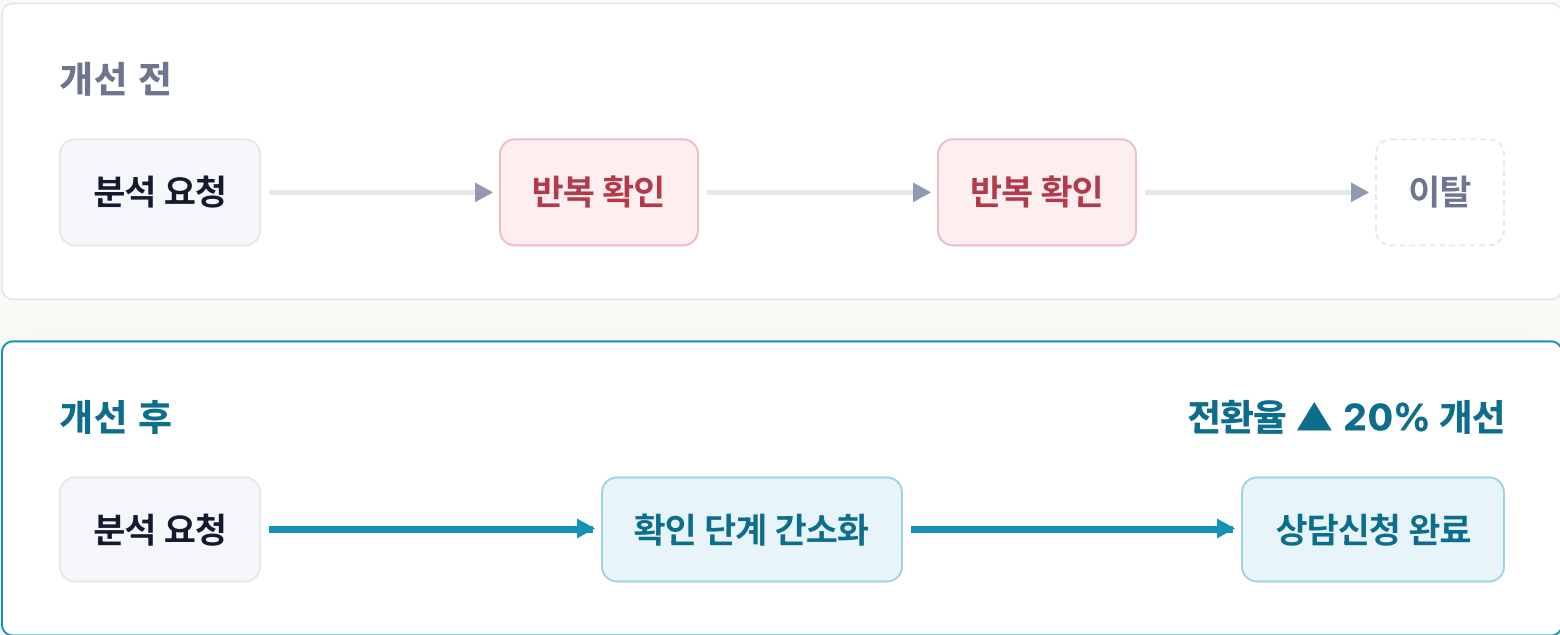
— 페이지 수정 전 대비, 해당 페이지의 상담신청 전환율

20% 개선

보험분석 상담신청 페이지 · 수정 전 대비

문제	상담신청 과정의 반복 확인 단계가 고객 부담·이탈 요인
실행	반복 부담을 확인하고, 확인 단계와 신청 흐름을 개선
결과	수정 반영 후 전환율 기존 대비 20% 개선
함께 확인	설계사 클레임 비율도 함께 점검해 상담 정보 품질 확인

신청 과정 개념도 · 실제 화면 아님



직배송 확인 업무를 시스템으로 구조화

— 일일 처리업무 약 6시간 → 약 2시간 · 고물량 제조사 적용 구간 기준

개선 전	재고 미보유 주문의 수기 확인 ·제조사 개별 연락, 진행·예외 확인에 업무 집중
본인 변경	주문 상태·처리 흐름 을 정리하고, 담당 업무·예외 처리를 관리자 시스템 에 반영
적용	제조사별 운영 여건에 맞춰 적용

약 30%

보조 근거 · 수급자 조회·관리 기능 이용률
수급자 자격·급여 기준·구매 정보 조회·관리 기능을 함께
고도화

일일 처리업무 시간 비교



EMR API와 환자 이용 흐름을 연결한 원무 서비스 기획



1

원무 모바일 서비스
환자 이용 흐름 · 운영 확인 · 예외 처리 고려

▲ 기존 API 연동 (수행)

2

기존 EMR API
업체가 제공하는 데이터·기능 범위

▲ 원무 절차 기반 기능 검토·조율 (수행)

3

병원 원무 절차
병원·EMR사·개발조직 요구사항 조율

제안 · 검토 (수행 아님)

반복 기능의 공통화

병원 공통 통합 플랫폼 방향

완성한 성과가 아니라, 검토·제안 단계

수행 (기존 API 기반 기획·조율) 제안·검토 (공통화·통합 방향)	병원별 차이 기관마다 요구사항이 다름	EMR 업체별 차이 제공 데이터·기능이 상이	추가 개발·협의 협의·비용이 별도로 필요
--	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

여러 사업의 요청을 우선순위와 팀별 책임으로 정리

본인 · 팀장
3개 팀 운영

코나카드	직접 겸직
지역화폐	팀장 중심 운영
모빌리티	팀장 중심 운영

우선순위 판단 기준

- 외부와 합의한 일정·약속
- 법률·운영 위험
- 여러 요청을 함께 해결할 공통 과제

실행 관리

- 업무 배분과 백로그 정리
- PRD 목적·KPI ↔ 상세기획 연결 확인
- Figma 기반 산출물 공유·협업

DAI 적용 어려운 요구가 생기면 범위·일정·내부 인력·외부 협업의 선택안을 비교하고, 경영진 판단이 필요한 사안에는 추천안을 제시하겠습니다.

AI로 요구사항을 구체화하고, 적용 효과와 운영 품질을 함께 검토

지금까지 · 수행 · 만든다

AI로 초안을 빠르게 만든다

- PRD · 기능정의 · 프로토타입 제작
- 테스트 데이터를 연결한 작동 프로토타입
- 사내 운영 업무의 도구화 · 자동화



DAI · 적용 · 판단한다

정식 적용은 4가지 기준으로

- 효과** 어떤 사용자·운영 문제를 개선하는가
- 오류·누락** 결과의 오류·누락을 어떻게 확인하는가
- 사람 검토** 어떤 상황에서 사람이 검토하는가
- 비용** 데이터·연동·보안·운영 비용을 감당할 수 있는가

적용 예시

정보 요약 기능이라면 **처리시간**과 **중요 정보 누락**을 함께 평가

향후 접근법입니다. 실제 의료 AI 성과가 아니며, 임상·규제는 전문가와 함께합니다.

사업 목표와 실행 조건에 따라 검증하고 확장

1 사업 · 현장 이해 ? 실제 사용자·도입 결정자·비용 주체와 기존 데이터·계약 조건은? 판단 결과 해결할 문제와 기대 성과 합의	2 우선 과제 선정 ? 고객 영향·사업 효과와 데이터·개발·운영 가능성은? 판단 결과 우선순위와 개발 범위 제안	3 불확실성 검증 ? 수요·연동·AI 품질·운영 중 핵심 불확실성은 무엇인가? 판단 결과 진행 · 범위 수정 · 보류 판단	4 구축 · 개선 · 확장 ? 실제 이용·운영 결과와 공통 활용 가능한 기준은? 판단 결과 보완 · 확대 여부 결정
--	---	---	---

← 검증 결과에 따라 앞 단계로 되돌아갈 수 있고, 이미 검증된 부분은 이어받습니다

경영진에게는 **선택의 근거와 추천안**을, 실행 조직에는 **명확한 범위와 판단 기준**을 제시하겠습니다.

먼저 증명할 두 가지 실행 가설



① 가설 A · 환자 경험 연결
진단·모니터링·관리를
하나의 환자 여정으로 잇는다

가설	접점이 지금은 따로 쓰인다. 만성질환자에게 측정·해석·다음 행동 이 한 여정으로 이어지면 측정 지속과 후속 연결이 좋아진다
근거	그룹은 진단·모니터링·관리 접점(닥터눈·하이카다·케어센스케어)을 이미 갖고 있다. 이를 잇는 경험은 아직 없다
검증	만성질환자 일부를 대상으로 두 접점을 먼저 연결 해 측정 지속과 다음 행동 연결을 관측
성공·중단	측정 지속·행동 연결 ↑ + 안전 인시던트 0 + 동의·규제 통과 → 확장 / 미달 → 축소·보류



② 가설 B · 데이터 플라이휠(RWD) ↻
여정에서 쌓인 데이터를
표준화해 개선에 재사용한다

가설	접점을 잇는 과정에서 쌓이는 데이터를 표준 형식으로 모으면 , 다음 개선과 근거 마련에 다시 쓸 수 있다
근거	접점이 따로 돌면 데이터도 흩어진다. 표준을 맞춰 모아 야 다시 쓸 수 있다
검증	한 여정에서 공통 데이터 기준 (동의·항목·포맷)을 정하고, 모아서 다시 쓰는 과정을 작은 범위로 시험
성공·중단	데이터 완결성·재사용 가능성 확인 + 동의·보안·규제 통과 → 확대 / 미달 → 표준 범위 재조정

확정된 계획이 아니라 **입사 후 살펴보며 정할 가설**입니다. 데이터는 **환자 동의와 보안·규제 범위 안에서만** 씁니다.

CLOSING

DAI의 사업 과제를 제품과 운영으로 구체화하겠습니다

01 전환

사용자 행동과 사업 전환을 함께 본 경험

02 연동

현장 업무와 외부 시스템을 연결한 경험

03 실행

우선순위를 정하고 여러 팀의 실행을 이끈 경험

필요한 전문성과 협업하며, 판단의 근거와 실행 결과를 끝까지 설명하는 팀장이 되겠습니다.